

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**

**ANTONIO MATHEUS DA SILVA BATISTA**

**NECESSIDADE EM SAÚDE VS. OFERTA DE SERVIÇOS:  
UMA ANÁLISE ECONÔMICA DAS DESIGUALDADES REGIONAIS NO  
FINANCIAMENTO DA SAÚDE**

Docente: Prof. Dr. Carlos Magno

**CUIABÁ - MT  
22/06/2026**

## **1. INTRODUÇÃO**

A Economia da Saúde consolidou-se como uma disciplina independente nas décadas de 1950 e 1960, impulsionada pela necessidade de introduzir critérios racionais na gestão de recursos escassos frente a demandas sociais ilimitadas e crescentes. O artigo seminal de Kenneth Arrow (1963), *Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care*, estabeleceu que o setor saúde possui particularidades intrínsecas — como externalidades, incerteza e assimetria de informações — que impedem o funcionamento de um mercado de concorrência perfeita.

No contexto brasileiro, a saúde e a assistência dominam o cenário político e econômico. O Brasil é um país de dimensões continentais marcado por profundas desigualdades regionais e sociais. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 1990 propôs a universalidade e a equidade no acesso; entretanto, a operacionalização desses princípios esbarra constantemente no subfinanciamento e na má alocação de recursos. Este artigo objetiva analisar, sob a lente econômica, o hiato entre a necessidade em saúde da população e a oferta de serviços, com ênfase nas disparidades de financiamento entre as regiões brasileiras.

## **2. NECESSIDADE, DEMANDA E A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Na economia clássica, a "demanda" está atrelada à capacidade e disposição de pagar por um bem ou serviço. Na saúde, porém, introduz-se o conceito de "necessidade", que possui um caráter clínico e social. O acesso aos serviços de saúde, idealmente, deveria ter por substrato o princípio da necessidade (quem precisa mais, deve receber mais), e não o poder de compra.

A oferta de serviços de saúde lida com a resposta social organizada para prover assistência a uma comunidade. Contudo, essa oferta não se distribui de maneira uniforme. A alta complexidade, a exigência de credenciamento e os altos custos de formação de profissionais (especialmente médicos) criam barreiras de entrada que caracterizam o mercado de saúde como imperfeito. Quando a regulação estatal falha em corrigir essas imperfeições, a oferta tende a se concentrar em regiões de maior viabilidade econômico-financeira (geralmente os grandes centros urbanos do Sul e Sudeste), deixando vastas áreas desassistidas.

### 3. O CUSTO DE OPORTUNIDADE E AS DESIGUALDADES REGIONAIS

Para compreender o impacto das escolhas de financiamento e alocação de recursos, a Economia da Saúde utiliza o conceito de **Custo de Oportunidade** (ou Custo Social). Este conceito refere-se ao valor da melhor alternativa preterida ao se tomar uma decisão econômica. Quando aplicamos essa premissa à realidade brasileira, o hiato entre o princípio constitucional da equidade do SUS e a prática torna-se quantificável.

De acordo com os dados da **Demografia Médica 2024**, divulgados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil vivencia um verdadeiro paradoxo de abundância e escassez. Embora o total de médicos no país tenha dobrado nos últimos 15 anos (passando de 292.794 em 2009 para 575.930 em 2024) e a proporção nacional tenha atingido a marca de 2,81 médicos para cada mil habitantes — índice superior ao de países como Estados Unidos e Japão —, a alocação dessa força de trabalho reflete as graves distorções e imperfeições do mercado de saúde nacional.

A distribuição da oferta profissional não acompanha a "necessidade em saúde" demográfica, mas sim a atratividade econômico-financeira e a infraestrutura instalada. Os dados de 2024 ilustram de maneira contundente essa assimetria regional:

- **Fosso Regional:** A região Sudeste concentra a maior oferta, com 3,76 médicos por mil habitantes, enquanto a região Norte possui a menor proporção do país, com apenas 1,73. O Nordeste também amarga índices abaixo da média nacional (2,22), contrastando com as melhores realidades do Centro-Oeste (3,39) e do Sul (3,27).
- **Concentração Capital vs. Interior:** A desigualdade é ainda mais brutal quando observada sob a lógica de urbanização. As capitais brasileiras ostentam uma média de 7,03 médicos por mil habitantes, enquanto o interior possui apenas 1,89. Exemplos extremos evidenciam a ineficiência distributiva: Vitória (ES) possui a maior densidade, com 18,68 médicos por mil habitantes, ao passo que o interior do Amazonas agoniza com míseros 0,20 médicos por mil habitantes.

Diante desse cenário, a teoria econômica explica que profissionais de alta formação técnica tendem a concentrar-se nas áreas onde já existem recursos, hospitais de excelência e poder de compra. Quando o Estado é ineficiente na regulação e não corrige essa falha alocativa por meio de repasses justos de financiamento, perpetua-se um ciclo de escassez assistencial nas áreas vulneráveis.

Um exemplo clássico na literatura de gestão pública em saúde no Brasil (frequentemente citado em análises do antigo INAMPS e transposto para os dilemas atuais do

SUS) ilustra perfeitamente essa dinâmica da escolha sobre o financiamento: *Imagine que o volume de recursos gastos pelo Estado para custear o tratamento de altíssima complexidade de apenas 137 pacientes na rede privada das regiões abastadas seja equivalente a uma grande porcentagem dos recursos que podem ser transferidos às secretarias estaduais de saúde do Norte e Nordeste.*

O custo de oportunidade de concentrar o financiamento nesses poucos tratamentos — ou de permitir que a formação e fixação de profissionais ocorra apenas no eixo Sul-Sudeste — não é meramente contábil. Seu custo real, social e humano, equivale às vidas perdidas ou agravos acumulados no interior das regiões Norte e Nordeste, onde as necessidades básicas em saúde continuam desassistidas frente ao descompasso da oferta de serviços.

#### **4. A AVALIAÇÃO ECONÔMICA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO**

A ausência de critérios econômicos na alocação de recursos gera ineficiência e aprofunda as desigualdades. Tradicionalmente, as profissões de saúde operam sob uma ética individualista: a vida não tem preço e justifica qualquer esforço. A economia, por outro lado, fixa-se na ética do bem comum e do coletivo, reconhecendo os limites orçamentários.

Para mediar esse conflito, a Avaliação Econômica em Saúde (estudos de custo-efetividade, custo-utilidade, cálculo de DALYs — *Disability-Adjusted Life Years*) torna-se indispensável. Ela permite que os formuladores de políticas públicas identifiquem a alocação ótima dos recursos disponíveis para maximizar a saúde da população como um todo.

O papel do Estado na regulação da oferta e demanda é imperativo. Políticas de transferência fundo a fundo e critérios de rateio que priorizem as necessidades epidemiológicas (pobreza multidimensional, índices de mortalidade) em detrimento apenas da capacidade instalada (que privilegia quem já tem mais hospitais) são fundamentais para reverter a concentração regional do financiamento.

#### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O hiato entre a necessidade em saúde e a oferta de serviços no Brasil não é apenas um problema de escassez absoluta de recursos, mas primariamente um problema de alocação ineficiente e desigualdade regional. A Economia da Saúde não deve ser vista pelos profissionais da área como uma disciplina árida focada em cortar gastos, mas sim como um recurso orientador para a justiça social.

Fazer escolhas é inevitável. Enquanto o Estado brasileiro não alinhar o financiamento da oferta de serviços às reais necessidades demográficas e epidemiológicas de suas regiões

mais carentes, o custo de oportunidade continuará sendo pago com a saúde e a vida das populações mais vulneráveis. O desafio permanente do SUS, portanto, é utilizar a racionalidade econômica para garantir a efetividade de seus princípios constitucionais: a equidade e a integralidade.

### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- ARROW, K. J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. *The American Economic Review*, v. 53, n. 5, p. 941-973, 1963.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Sistema Único de Saúde (SUS): Princípios e Diretrizes*. Brasília, DF.
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). *Demografia Médica 2024*. Brasília: CFM, 2024. Disponível em fontes de divulgação oficial do CFM e Educa Mais Brasil.
- PIGOU, A. C. *The Economics of Welfare*. Londres: Macmillan, 1920.
- PIOLA, S. F.; VIANNA, S. M. (Org.). *Economia da Saúde: conceito e contribuição para a gestão da saúde*. 2ª ed. Brasília: IPEA, 1995.